

Repaso Examen de Ley-D.

1. **Propósito de la creación de la Junta de Farmacia:** Responsable de salvaguardar la salud del pueblo, con poder exclusivo para reglamentar la admisión, suspensión o separación del ejercicio de la profesión de farmacia y de la ocupación de técnico de farmacia.
2. **¿Quién nombra los miembros de la Junta?** El Gobernador de Puerto Rico de lista sometida por el CFPR o por la Junta de Farmacia o no incluido en la lista. El gobernador por iniciativa propia o por petición de La Junta podrá separar del cargo por negligencia en funciones como miembro de la Junta o del ejercicio de la profesión u ocupación por cualquier asunto que tenga que ver con delito grave, menos grave o falta de ética.
3. **Función del técnico de farmacia:** Podrá desempeñar, bajo supervisión directa del farmacéutico, funciones técnicas o administrativas relacionadas con la dispensación de medicamentos y artefactos mediante receta que le delegue el farmacéutico y que NO requieran juicio farmacéutico.
 - a. NO podrá verificar recetas, ni orientar al paciente sobre medicamentos recetados.
 - b. NO podrá ejercer ninguna otra de las funciones del farmacéutico.
4. **Requisitos para ejercer como Farmacéutico en Puerto Rico:**
 - a. **Licencia-** Otorgada por la Junta de Farmacia
 - b. **Colegiación-Membresía CFPR,** \$144 anuales (2018-2019)
 - c. **Recertificación-** por oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud (ORCPS), Departamento de Salud **9 años**
5. **Horas de práctica de farmacéutico:** Completar un mínimo de 1,500 horas de práctica, previamente autorizadas por la Junta, bajo la supervisión de un farmacéutico preceptor. La Junta podrá aumentar el número de horas por reglamento, luego notificar con ≥ 1 año de anticipación a escuelas de farmacia en PR.
6. **¿Cuál NO es requisito para ejercer en PR por reciprocidad?** Cumplir con 1,500 horas de práctica.
7. **Colegiación:** Uno de los requisitos para ejercer en PR es ser miembro de CFPR. La cuota anual (2018-2019) es \$144. El CFPR fue creado por la Ley Núm. 243 de 15 de mayo de 1938.
8. **Educación continua:**
 - a. **Farmacéutico-total 35 hrs.**
 1. 10 horas tienen que ser presenciales **23 a distancia**
 2. 12 créditos (3 créditos c/u) obligados en: Control de infecciones, errores en medicación, ética, ley de farmacia.
9. **¿Quién tiene el poder/ejecutar decisiones en el colegio de farmacéuticos?** El comité ejecutivo.
10. **Horas de práctica de técnico de farmacia:** Completar mínimo de 1000 horas de internado autorizado por la Junta de Farmacia bajo supervisión directa de farmacéutico

preceptor en una farmacia. La junta podrá aumentar por resolución aprobada por todos los miembros de la junta, el número de horas de internado requerido, luego de notificar a las instituciones con ≥ 1 año de anticipación.

11. ¿Quién puede quitar la licencia, cese y desista, multa, suspender, cancelar, revocar

licencia a los farmacéuticos y técnicos de farmacia? La Junta de Farmacia según establecido en la Ley 247 de 2004 (Ley de Farmacia) y por el Reglamento de la Junta.

12. ¿Qué ocurre con la Licencia de establecimientos al cambiar de dueño o lugar?

Cuando un establecimiento cambie de dueño o local, la licencia será nula y se entregará al Departamento de Salud para proveerse de una nueva.

13. Licencia de establecimientos: Según el Reglamento Núm. 156, la licencia se renovarán

cada 2 años en forma escalonada mediante solicitud escrita completada con la información requerida por el Departamento de Salud, acompañada del importe (\$) correspondiente. Toda solicitud debe estar en SARAFS no más tarde de 45 días calendarios anteriores a la fecha de vencimiento.

14. ¿Quién deniega, suspende, cancela o revoca licencias de establecimientos? Según el

Reglamento 156, el Secretario de Salud podrá denegar la solicitud de licencia, autorización o certificado si no cumple con los requisitos. Todo tenedor de licencia, autorización o certificado a quien se le haya notificado una querrela de suspensión, cancelación o renovación tendrá derecho a solicitar una vista administrativa.

15. ¿Cuántos farmacéuticos se necesitan en una farmacia, institución o droguería?

Según el reglamento 156, los establecimientos que requieren farmacéutico contarán con el número de farmacéuticos que razonablemente sean necesarios para proveer los controles y servicios que se requieren para cada actividad.

16. Falta de farmacéutico:

- a. **Cambio o cese de empleo:** Todo dueño, administrador o encargado de un establecimiento que requiere farmacéutico notificará por escrito a la División de Medicamentos y Farmacia dentro de 3 días laborables. Reglamento Núm 156.

17. Ausencia de Farmacéutico:

- a. **Ausencia en Industria:** Toda ausencia de farmacéutico en industria farmacéutica, droguería o distribuidor al por mayor de medicamentos de receta, no cubierta por otro farmacéutico, será notificada por el dueño, administrador o encargado dentro de las 24 horas de ocurrida a la División de Medicamentos y Farmacia. La división requerirá evidencia de gestiones realizadas.
- b. **Ausencia en Recetario:** Sólo podrá ocurrir en caso de emergencia. El dueño, representante o funcionario encargado en la farmacia registrará inmediatamente la ausencia. El farmacéutico tendrá 24 horas desde que ocurre la emergencia para completar el Registro, con hora y razón que motivó la ausencia y la fecha y hora en la que regresó. Tienen que colocar el rótulo: RECETARIO CERRADO POR EMERGENCIA DE FARMACÉUTICO.

c. **Ausencia en Recetario durante el periodo de alimentos:** El farmacéutico anotará en un registro separado del registro de ausencia de farmacéutico por emergencia, la hora de salida para tomar alimento y la hora de reintegro al recetario, cuando ello resulte en la ausencia del farmacéutico. Si la ausencia se extiende por menos de una hora, no se requerirá colocar el rótulo.

18. **Ausencia de preceptor:** Durante ausencia del farmacéutico preceptor, el interno de farmacia o de técnico de farmacia, no podrá realizar funciones relacionadas con la dispensación de medicamentos de receta. El proceso de dispensación incluye desde recibir hasta despachar.

19. **Temperatura de productos biológicos:** 12.5 grados centígrados o 55 grados Fahrenheit. En el examen vinieron las dos, la diferencia es que el C del 12.5 tenía un punto al final de la C (12.5 C.) y el del 55 grados solo tenía la F, sin el punto. Las siglas no tienen el punto, so supongo que es 55. (pág. 60, HO 2)

20. **Conservación de expediente de vacunación del paciente:** Conservar expediente confidencial de vacunación de cada paciente en lugar seguro del recetario a perpetuidad, disponible para evaluación del Inspector de la División de Medicamentos y Farmacia.

21. **Vacunas que no necesitas receta:** Neumococos, Influenza, Td/Tdap.

22. **Licencia de botiquín:**

- a. **En Institución-** asilos, casas de convalecencia, dispensario en fábricas, instituciones penales, etc.
- b. **En Ambulancia-** La licencia pertenece a la estación de ambulancias Categoría III.
- c. **En Institución Educativa*-** en instituciones de educación superior, mediante la cuál podrá adquirir y conservar medicamentos necesarios, única y exclusivamente para ser utilizados en la enseñanza.

23. **Certificado de registro trienal:** Certificado de Registro Trienal de Medicamentos en Oficina Médica o Registro Trienal de Medicamentos y Productos Biológicos en Oficina Médica.

- a. **Instituciones de Educación Superior:** Que adquieran, almacenen y administren medicamentos que sean parte de un ensayo clínico aprobado por la FDA.
- b. **Médicos, Dentistas y Podiatras.**

24. **División de Medicamentos y Farmacia**

- a. La Secretaria de Salud podrá delegar la función de fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento, además de cualesquiera otras funciones relacionada, a la División de Medicamentos y Farmacia, adscrita a Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud.
- b. La división de medicamentos y farmacia estará dirigida por un farmacéutico con no menos de cinco (5) años de experiencia y contará con un número adecuado de inspectores para llevar a cabo sus funciones fiscalizadoras.
- c. La Secretaria establecerá un adiestramiento para la formación de los inspectores.

25. Medicamentos para uso de animales: El veterinario no necesita licencia de registro trienal ni de botiquín. Necesita licencia de instalación veterinaria. Los medicamentos veterinarios pueden ser dispensados en un establecimiento debidamente autorizado por la Secretaria de Salud (Centro Agrícola).

26. Información de receta que se le puede preguntar al paciente si falta: Nombre, Dirección, Edad.

- a. ¿Que se le puede preguntar al médico? Fecha de la receta e información sobre el o los medicamentos. Cualquier cambio o arreglo a la receta se anotará al dorso con fecha, hora, vía de comunicación y persona que brindó la información y escribirá sus iniciales o firma.

27. Transmisión de la receta para acelerar el proceso: Para acelerar el proceso de la dispensación de una receta, su contenido podrá transmitirse por medio oral, fax, imagen digitalizada o comunicación electrónica por el propio paciente o su representante, o por el prescribiente a la farmacia libremente seleccionada.

- a. Toda receta recibida por los medios antes mencionados se documentará con fecha, hora y persona que hizo la transmisión.
- b. La receta original se entregará al farmacéutico antes de entregar los medicamentos.
- c. El farmacéutico archivará la receta original adherida a la transmisión de la receta transmitida por medio oral, fax, imagen digitalizada o comunicación electrónica. No aplica a Rx electrónicas.

28. Suplido de Emergencia: En caso de emergencia en se despacharán suplidos para 5 días. El prescribiente tiene que enviar la receta en un periodo no más de 5 días (120 horas) de lo contrario, el farmacéutico tiene que notificarlo a la división de medicamentos y farmacia. La receta original debe incluir la palabra EMERGENCIA. Se considera emergencia cuando (todas):

- a. La administración inmediata del medicamento es necesaria para el tratamiento adecuado del paciente.
- b. No hay medicamento sin receta que constituya alternativa apropiada para dicho tx
- c. No es razonablemente posible para el prescribiente proveer o para el paciente obtener la Rx escrita antes de la dispensación.

29. Receta en EE.UU: Se permite en PR la repetición de recetas expedidas por facultativos autorizados a ejercer en cualquier estado de EU, cuyo original haya sido dispensado en el estado de procedencia. Rx no puede tener más de 3 meses. Se documentará nombre de la farmacia donde se encuentra la receta original, nombre del farmacéutico que la transfiere, nombre de la farmacia y del farmacéutico que repitió la Rx y número de repeticiones restantes, si alguna.

30. Medicamentos intercambios bioequivalentes: Se interpretará que el prescribiente ha prescrito cualquier medicamento bioequivalente a menos que haya escrito a mano o electrónicamente la frase “No intercambie” o una abreviatura que comunique la misma

intención. El medicamento Bioequivalente es el que sale en Orange Book (Tienen idéntico código de equivalencia terapéutica, letras y números, al de marca comenzando con la letra A). Paciente o representante debe firmar al dorso de la rx si desea el intercambio a medicamento bioequivalente.

- a. Sólo en los casos en que la farmacia no tenga disponible un bioequivalente de menor precio ni el medicamento de marca prescrito, el farmacéutico podrá dispensar un medicamento bioequivalente de igual precio al medicamento prescrito, previo consentimiento del paciente. El intercambio se realizará para proporcionar un ahorro económico al paciente.

31. Máximo de empleados que el farmacéutico puede supervisar: 5 personas en total en un mismo horario

- a. 5 técnicos de Farmacia
- b. 4 técnicos de farmacia y 1 interno de técnico o interno de farmacia (Pharm.Dc.)

32. Entregas de medicamentos al hogar/domicilio: El paciente puede renunciar a que sea el farmacéutico quien entrega el medicamento y acogerse a un servicio de entrega a domicilio, sin necesidad de designar a un representante autorizado, siempre que no sea requerido como condición y que haya autorización expresa por escrito del paciente.

33. Evidencia de renuncia a entrega u orientación: La evidencia requerida documentará fecha, hora y nombre del paciente o de su representante, la misma se archivará durante 2 años en el expediente farmacéutico.

34. Medicamentos Bioequivalentes: Se requiere la firma del paciente o representante para cambiar a un medicamento bioequivalente. Si la Rx es electrónica, se verifica el perfil del paciente para conocer si utiliza el bioequivalente o marca. Si el médico indicó "NO INTERCAMBIO" y el paciente si desea el bioequivalente, hay que comunicarse con el médico para obtener autorización. La autorización del prescribiente se documentará en el expediente del paciente o al dorso de la Rx indicando fecha y hora en que se obtuvo la autorización.

35. Cuando se hace el cambio de Brand a bioequivalente: Todo medicamento dispensado mediante receta contendrá:

- a. Nombre, dirección y teléfono de la farmacia que dispensó
- * b. Número de Rx
- * c. Nombre de marca, si se dispensó un medicamento de marca o nombre genérico y su manufacturero o distribuidor, si se dispensó un medicamento generico (ej. Simvastatin [Zocor])
- d. Potencia o concentración del medicamento
- e. Indicaciones específicas de uso
- f. Nombre y apellidos de paciente y medico
- * g. Fecha de exp. y Número de lote

36. ¿Qué NO es necesario en el label del medicamento dispensado? Edad del paciente

37. Fecha de expiración de los medicamentos dispensados mediante receta (Beyond Use

Date): Se entenderá como fecha de expiración la fecha a partir de la cual el medicamento no deberá ser utilizado.

a. Medicamentos dispensados en un mismo envase para más de una dosis: le fecha de expiración del producto indicada por el fabricante o un año desde la fecha de dispensación, lo que sea menor.

b. Medicamentos sólidos o líquidos en dosis unitarias: La fecha del fabricante o un año desde su re-empaque, lo que sea menor.

c. Compounding

1. Formulación sólida o líquida no acuosa: 6 meses

2. Contiene agua y se confecciona a partir de ingredientes sólidos: 14 días en nevera.

3. Cualquier otra formulación (cremas, lociones, etc): 30 días

38. Intercambio biológico por biosimilar: Farmacéutico puede realizar el intercambio sí:

a. El producto está aprobado como intercambiable con el recetado. Aparece en el Purple book o Orange Book como intercambiables.

b. El médico no indique en la receta la frase "No intercambiable"

1. En este caso el farmacéutico tiene que indicarle al paciente que existe un biosimilar intercambiable y paciente acepta o rechaza el intercambio

2. De ocurrir el intercambio, el farmacéutico tiene que informarle al médico en un periodo no mayor de 2 días el producto específico que se le despachó al paciente, incluyendo el nombre del producto y el fabricante.

39. Dispositivos médicos y/o artefactos: La ley de farmacia dispone que todo dispositivo o artefacto aprobado por FDA y registrado en su página electrónica, estará exento de registro ante el Departamento de Salud.

40. Ley #73 de 2007: Elimina jeringuillas de la definición de Parafernalia de sustancias controladas.

a. Ley Núm. 64 de 2009: Autoriza recetas electrónicas de sustancias controladas

b. Ley Núm. 154 de 2012: Incluye cannabinoides en CI

41. Requisito para dispensación de narcóticos: El Reglamento 153 incorpora el requisito de dos (2) días desde expedición de receta de narcóticos para su dispensación. No importa que número de controlado sea el medicamento, si es narcótico se despacha en un periodo de 2 días.

42. Inspector de sustancias controladas: Agente del orden público nombrado por el Departamento de Salud; adiestrado por el Departamento de Justicia y/o Policía de PR. Fiscaliza aspectos relacionados con la fabricación, distribución, disposición final y dispensación de sustancias controladas en PR.

43. Autoridad y Procedimientos para control y clasificación de sustancias: El Secretario de Salud podrá incluir, transferir o eliminar sustancias de clasificación, o incluir precursores inmediatos en igual o más alta clasificación que la sustancia controlada, medicamento: (Importante los días)

a. Adopción por referencia de controles federales o mediante orden emitida 30 días después de la publicación en el Federal Register (FR).

b. Iniciativa propia mediante Reglamento u Orden Declarativa que serán publicados:

- 1.** Dentro de 30 días de ser aprobada por el Secretario en 2 periódicos de circulación general en PR.
- 2.** Entrarán en vigor 30 días después de su última publicación y de su radicación en el Depto de Estado de PR
- 3.** Se considerarán para todos los fines y efectos legales parte del Reglamento 153 de sustancias controladas como un anejo.
- 4.** El reglamento concede hasta 90 días desde la vigencia de la Orden para obtener o modificar registro, someter informes o inventarios, o devolver sustancias.
- 5.** Ordenes declarativas vigentes: Núm 32 que reclasifica marihuana a CII

El Secretario podrá objetar una Orden Federal:

- a. Dentro de 30 días de su publicación en Federal Register (FR)
- b. Publicando en 2 periódicos durante 2 días consecutivos las razones para si objeción y ofreciendo la oportunidad de tener vistas publicas en por lo menos 30 días después de su publicación
- c. Publicando su decisión final en 1 periódico durante 3 días.
- d. La decisión del Secretario será final y sólo podrá ser alterada mediante Legislación.

44. Medidas de seguridad de controlados: Para registrar un establecimiento que tendrá medicamentos controlados se requiere, entre otros, contar con medidas de seguridad:

- a. Medidas contra entradas no autorizadas para evitar hurto y alteración de sistemas de computadora o archivos electrónicos (Ej. Rejas, alarmas) para detectar entradas fuera de horas laborables y cámara de seguridad en recetario, área de recibo y almacén de sustancias controladas.

45. Denegación, suspensión y revocación del registro de sustancias controladas:

- a. **Estatat:** Secretario de Salud
- b. **Federal:** DEA

46. Medidas de Seguridad y conservación de sustancias controladas en otros establecimientos

- a. **Manufactureros y distribuidores:**

1. **Nivel Federal:** Deben conservar las sustancias CI y CII en caja de seguridad de más de 750 lbs empotrada al piso.
2. **Nivel Estatal:** El reglamento 153 no dispone medidas específicas sobre seguridad y conservación de sustancias en los establecimientos registrados en general.

b. Profesionales individuales

1. **Nivel Federal:** Deben mantener las sustancias CII-CV en gabinete cerrado.

47. Hojas oficiales de pedido de controlado: DEA Form 222

- a. **Nivel Federal:** Las hojas deben ser firmadas por la persona a quién se le expidió el registro o aquella a quien ésta autorizó a firmar las mismas mediante un poder notarial. Copia 1 para el distribuidor, copia 2 para el DEA y copia 3 para la farmacia
- b. **Nivel Estatal:** Distribuidor debe conservar copia de la hoja oficial por 2 años. El registrante que presente la hoja para controlados I o II también debe conservar copia.

48. Quién puede expedir controlados y que necesitas poder para hacerlo: Según la ley de sustancias controladas y reglamento 153, se reconoce autoridad para prescribir sustancias controladas a médicos, dentistas, veterinarios o podiatras, autorizados a ejercer su profesión en PR, debidamente registrados por el Secretario de Salud y DEA o exentos de registro

- a. tiene que tener licencia de registro profesional en PR, licencia de DEA y Estatal de ASSMCA (secretario de salud) o estar exento de los registros.

49. Dispensador que se prescribe así mismo:

- a. Se considerará consumidor final al dispensador que se prescribe a sí mismo sólo en los casos que el Secretario establezca mediante Reglamento.
 1. Ningún reglamento del Secretario de salud ha dispuesto los casos en que aplicaría esta disposición.

50. Cambios en la receta de controlados: Nivel Federal, lo estatal no dispone al específico sobre esto.

- a. El farmacéutico puede añadir o cambiar lo siguiente en la receta, previa autorización del prescribiente y documentando su acción: forma de dosificación, concentración, instrucciones para uso y fecha de expedición.
-  b. No se le permite hacer cambios en el nombre del paciente, la sustancia controlada recetada, la firma del prescribiente.
- c. Puede añadir información que provea el paciente luego de verificarla

51. Despacho de narcóticos: No se despachará ninguna receta por drogas narcóticas transcurridos dos días después de la fecha de su expedición.

52. Repetición de narcóticos: ya sean Control II, III, IV o V; no tienen repetición.

53. Repetición de controlados NO ^{narcóticos} controlados: 5 refills en 6 meses. Recordar que la receta dura 6 meses.

54. Orientación e información escrita para el paciente: El no facilitar al paciente un resumen impreso que incluya las advertencias por el uso incorrecto y los efectos secundarios por el uso de medicamentos **conlleva infracciones técnicas graves.**

55. Infracciones Técnicas e Infracciones técnicas graves:

a. Infracciones técnicas graves:

- 1.** Cualquiera relacionada con medidas de seguridad aprobadas previa expedición del registro
- 2.** Falta o exceso de sustancias controladas en inventarios físicos
- 3.** Movimiento de sustancias por cambio de dueño, de dirección, remodelación o modificación del recetario, sin previa autorización del Secretario o su representante autorizado.
- 4.** Dejar de notificar a la Oficina cambio de nombre o de razón social del registrante
- 5.** Cualquiera relacionada con informes, records o inventarios requeridos
- 6.** Dejar de notificar por escrito a la oficina de derrames o pérdidas de sustancias controladas en 5 días calendario
- 7.** Dejar de notificar carácter de adicto a empleado del registrante
- 8.** Dejar expirar el certificado de registro por mas de 5 días
- 9.** Obtener posesión de sustancia controlada, mediante compra u otro medio, de fabricante, distribuidor o dispensador no registrado
- 10.** No fijar el rotulo del envase info del establecimiento y medicamento; no facilitar medguide
- 11.** Compra de sustancias controladas expiradas
- 12.** Cualquier infracción al Reglamento o la Ley que a Juicio del secretario o se representante autorizado amerite.

56. ¿Quién reclasifica controlados? El secretario de Salud mediante órdenes administrativas.

57. Recomendación para uso de cannabis medicinal: Se justifica su recomendación a pacientes con condición medica debilitante

- a.** La recomendación médica establecerá como mínimo: Suministro max de 30 días
 - 1.** Nombre completo, dirección física, teléfono/email, fecha de nacimiento, condición medica debilitante, vía de consumo y tiempo recomendado para su uso del Cannabis Medicinal
- b.** Condiciones debilitantes nuevas que aparecen en el reglamento actual (Num 9038 -2018): **Depresión, Glaucoma, PTSD, Trastorno Bipolar**
- c.** **Ley Núm 42 de 2017: Ley MEDICINAL**
- d.** Reglamento 9038 de 2018- el que está vigente actualmente.

58. Persona que quiera dispensar cannabis medicinal: Personas interesadas en dispensar cannabis medicinal tiene que tener una **licencia ocupacional válida.**

- a.** La Junta **podrá requerir preparación académica** para algunas posiciones que forman parte de la industria de cannabis. En **Connecticut, Minnesota, New York, Pennsylvania y Arkansas,** **se requiere por Ley que sea un farmacéutico** quien dispense o supervise la dispensación de Cannabis para uso medicinal.

59. Ley del Buen Samaritano: Las personas legalmente autorizadas para ejercer la profesión médica en Puerto Rico que **fuera del curso y del sitio regular de su empleo o práctica profesional, voluntaria y gratuitamente presten servicios o asistencia de emergencia a cualquier persona en el ejercicio de sus funciones voluntarias, quedan exentos de responsabilidad civil cuando ocasionen perjuicio a las personas asistidas.**

- a.** Esta exoneración sólo será aplicable cuando los actos u omisiones realizados por las personas referidas en esta ley **no sean constitutivos de negligencia crasa,** o con **el propósito de causar daño.**

60. Medicamentos con requisitos especiales para ser despachados:

- a.** Radionucleares
- b.** Controlados
- c.** Biológicos